

CUIDADOS PALIATIVOS NO PACIENTE CIRRÓTICO



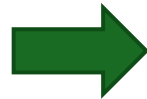
Bruna Scharanch

- Intensivista pelo HC FMUSP
- Clínica Médica e Graduação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
- Diarista da UTI da Gastroenterologia e transplantes do HCFMUSP e UTI Vila Nova Star



Cenário mundial

- Transição demográfica e epidemiológica
- Redução taxa mortalidade
- Redução taxa fecundidade



- Século passado: mortes repentinas – infecções, acidentes, partos

- Envelhecimento progressivo da população
- Aumento doenças crônico degenerativas incuráveis



- Atualmente: doenças crônicas – cardiovasculares, cerebrovasculares, cânceres, doenças respiratórias



- OMS – 5 milhões de pessoas morrem por ano no mundo
- Países desenvolvidos – 88% secundários a doenças crônicas
- Desenvolvimento tecnológico e científico:

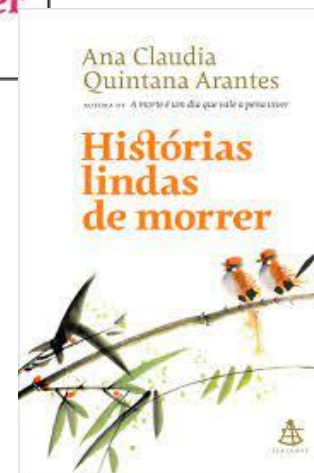


- Avanços na área da saúde com ganhos significativos em qualidade de vida
→ mas e o final de vida...



MORTE ainda é um verdadeiro tabu...

- Profissionais de saúde treinados na arte de curar ainda percebem a morte como um fracasso de sua atuação



BRASIL

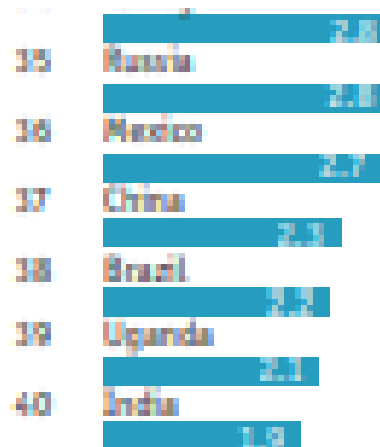
Brasil está entre os 40 piores países para morrer no mundo

País perde para Uganda em estrutura para fornecer tratamento adequado para pacientes terminais

The quality of death Ranking end-of-life care across the world

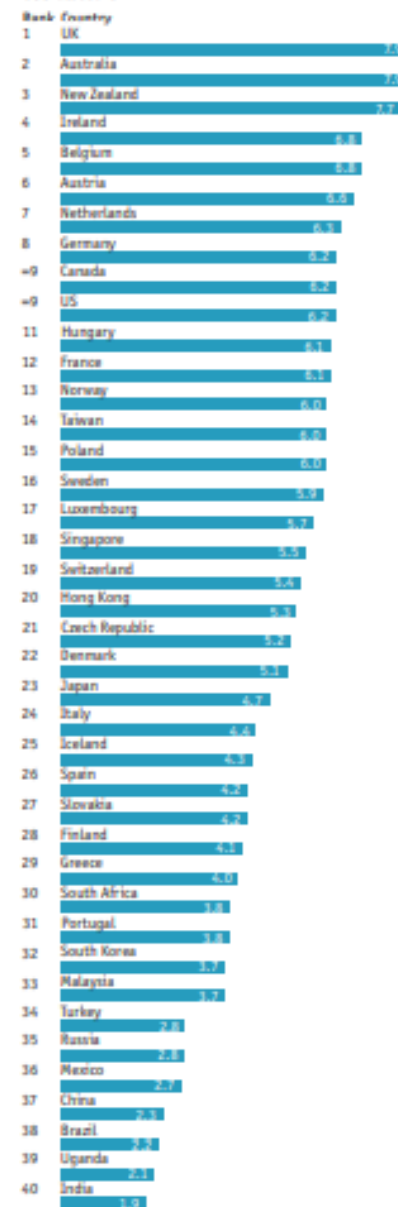
A report from the Economist Intelligence Unit

Commissioned by



Source: Economist Intelligence Unit.

Figure 1
Overall score



Source: Economist Intelligence Unit.

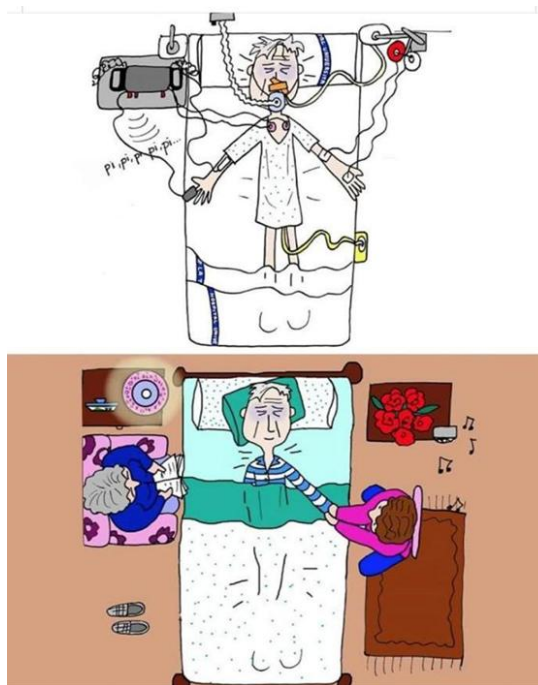


- Aumento do poder de intervenção
- Sem aumento na reflexão do impacto na qualidade de vida dos enfermos
- Evitar obstinação terapêutica



Apesar dos avanços da medicina moderna

- MORRER continua a ser uma condição humana
- Tecnologia: salvar vidas x tornar o final da vida extremamente doloroso, sofrido e solitário



Hepatopatas...



Casos

- Paciente 1: J.C – Tx – trombose – reTx – trombose – reTx → múltiplas abordagens – últimas foi “convencido” a assinar os termos cirúrgicos → alta da UTI – piora progressiva, definido CP na enfermaria
- Paciente 2: APRM, 45a, cirrose OH, não abstinência, internada por SHR, se negava a dialisar, ganhou um shiley e diálise no PS mesmo se recusando, paliada na UTI
- Paciente 3: HJAA, 38a, etilista ativo, desnutrido grave, pancreatite crônica agudizada, sem resposta satisfatória ao trial de UTI, esposa concordante com EOT paliativa e desejo de levar paciente para falecer em casa
- Paciente 4: CM, 70anos, pós TX recente, trombose artéria, biloma infectado multiR, piora função renal, não listado a curto ou médio prazo para Tx



Questionamentos???

- Todo cirrótico deveria acompanhar com Cuidados Paliativos?
- Quando acionar?
- Meu paciente é candidato a transplante?
- Minha terapia tem sido ponte para...?
- Paciente, família e equipe compreendem a doença e seu prognóstico?
- Trial de UTI – candidato, falência de trial, meu tratamento está sendo fútil?
- Quais ferramentas auxiliam na avaliação prognóstica?
- Compreendo o conceito de descompensação x ACLF (acute on chronic liver failure)?



PALIATIVO → *Pallium*

O vocábulo paliativo é derivado do latim *pallium*, que nomeia o manto usado pelos cavaleiros das Cruzadas para se protegerem das tempestades no caminho. A terminologia denota, então, a idéia principal dessa abordagem que é **cobrir, proteger e amparar**



Cuidado Paliativo

- ▶ Cuidado multiprofissional com enfoque na qualidade de vida dos pacientes e familiares, diante de **doenças ameaçadoras da vida**, prevenção e alívio de sofrimento não apenas físico, mas também psicossocial e espiritual
- ▶ WPCA – Worldwide Palliative Care Alliance → mais de 100 milhões de pessoas se beneficiariam de CP → < 8% tem acesso
- ▶ É imprescindível para um bom cuidado de saúde
- ▶ **Não se limitam a cuidados de fim de vida**
- ▶ Metas alcançáveis: controle de sintomas + terapias modificadoras de doença que alterem o curso natural na intenção curativa, comunicação clara e consistente, apoio psicossocial paciente e família, metas de cuidado mantendo valores do paciente e preferência



Quando falamos em pacientes cirróticos na UTI...

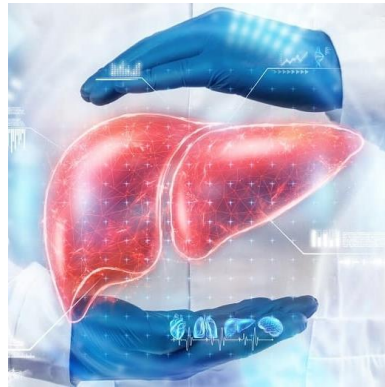
Na prática o que geralmente acontece...



Paciente cirrótico



Pode encontrar
cenários de Distanásia
Futilidade
terapêutica



Transplante

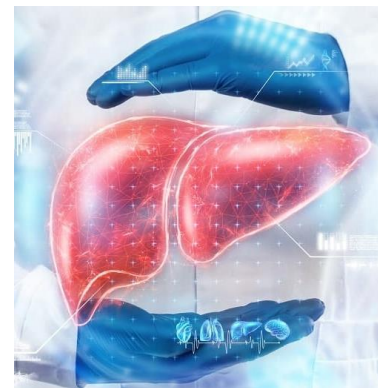


Cuidado Paliativo

Como deveria ser feito...



Paciente cirrótico



Transplante



Cuidado Paliativo



Cuidado integrado para evitar
distanásia e futilidade terapêutica



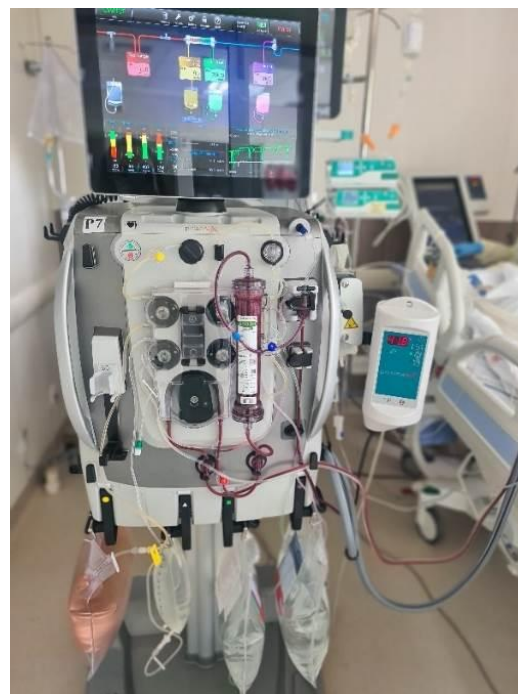
Futilidade terapêutica

- Tratamento considerado fútil é aquele cuja probabilidade de atingir um objetivo é baixa, expectativa de sucesso tão improvável que a sua exata probabilidade é muitas vezes incalculável
- Tratamento com potencial mínimo de benefício
- Envolve decisão individual a beira leito
- Latim “*futilis*” – derramamento, vaso furado – mitologia grega (o castigo das Danaides)
- Expressão “tonel das Danaides” passou a significar, figuradamente, o esforço infundável porque nunca termina; o trabalho feito repetidamente sem que nunca apresente um resultado proveitoso



Tomada de decisão ética

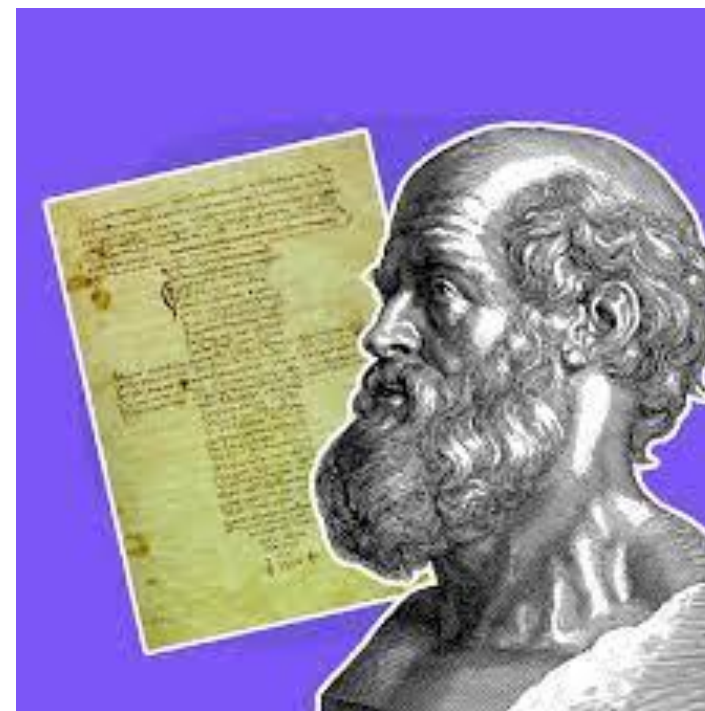
- ▶ Reconhecimento da futilidade
- ▶ Aplicação princípios éticos :
 - Autonomia
 - Beneficência
 - Não maleficência
 - Justiça



Lutar contra a futilidade não é fenômeno moderno → Hipócrates

- ▶ Remédio impróprio para causar mais fardo do que benefício
- ▶ Impróprio engajar-se em práticas sem esperança
- ▶ “Tentar tratamentos fúteis é exibir uma ignorância aliada a loucura”

Desacordos condutas a beira leito → envolvem diferenças de valores entre as partes envolvidas no reconhecimento da futilidade e quais resultados são considerados aceitáveis (equipes assistenciais, família, paciente)



Cirrose

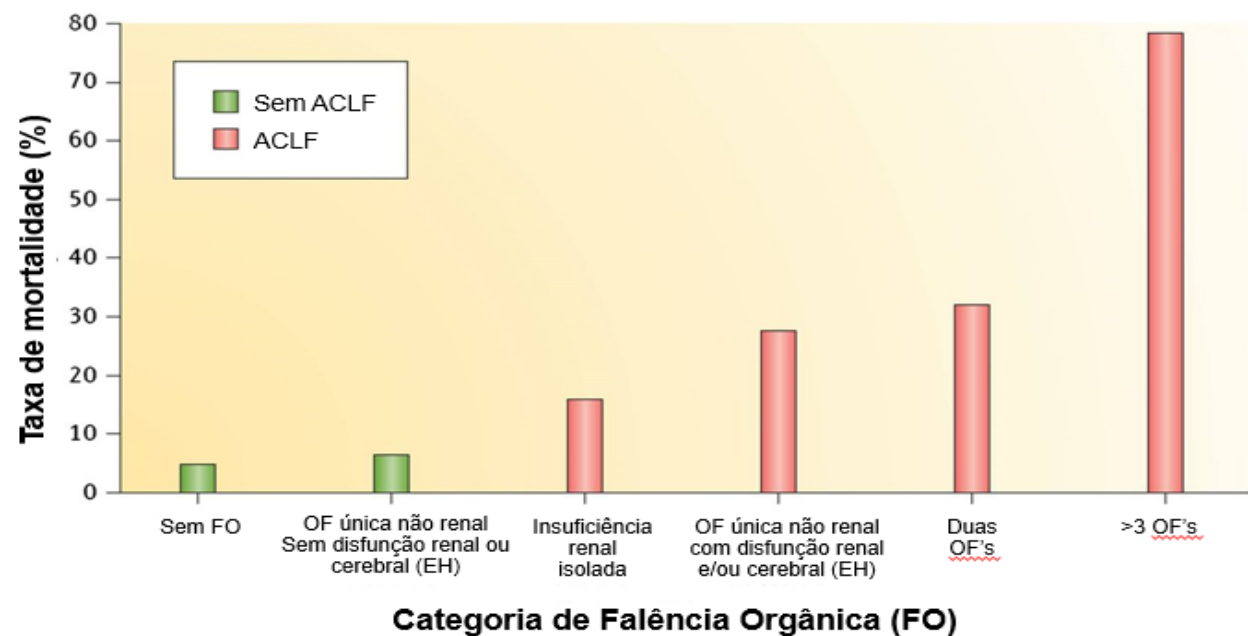


- Doença hepática terminal: progressão da doença hepática para cirrose, descompensação e insuficiência hepática crônica
- Hipertensão portal ou complicações relacionadas a insuficiência hepatocelular
- Inflamação e fibrose progressiva por várias causas: álcool, NASH, viral, auto imunes etc
- 2 estágios: compensados x descompensados → maior risco eventos adversos e maior mortalidade
- Compensado → 5-7% ao ano → descompensados
- Ascite, HDA, EH, icterícia, LRA, PBE, CHC, SHP, HPP

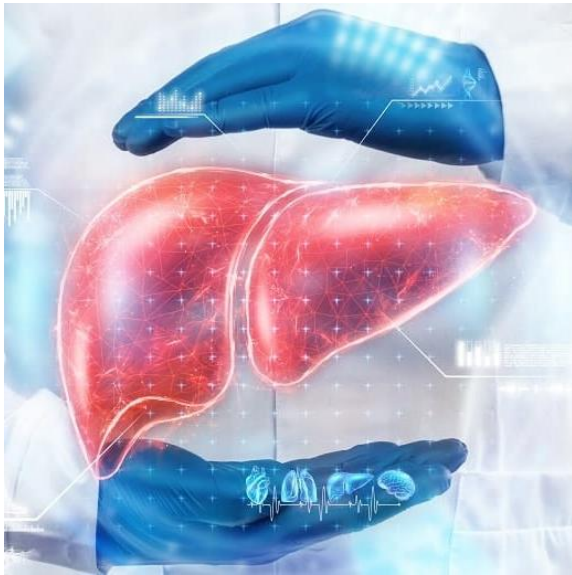


Descompensação X ACLF

Sem ACLF	ACLF grau 1	ACLF grau 2	ACLF grau 3
- Sem falência orgânica OU - Falência de 01 órgão que não envolva o rim (Cr < 1,5 mg/dL) e sem encefalopatia hepática OU - Acometimento do SNC com Cr < 1,5 mg/dL	- Insuficiência renal única OU - Insuficiência hepática OU de coagulação, OU circulatória OU pulmonar associada a Cr 1,5–1,9 mg/dL e/ou encefalopatia hepática grau 1 ou grau 2 OU - Acometimento do SNC com Cr entre 1,5 a 1,9 mg/dL	- Duas falências orgânicas em qualquer combinação	- Três ou mais falências orgânicas em qualquer combinação



Transplante hepático



- Oferece melhor sobrevida a longo prazo para os pacientes cirróticos
- Influenciado por fatores como:
 - Disponibilidade de doadores
 - Abuso substâncias ativas – não listados ou inativos
 - Progressão doença
 - Malignidade
 - Sepses
 - Envolvimento de órgãos extra hepáticos



O TRANSPLANTE COMO POSSIBILIDADE

- ▶ Antes de 1972, falências orgânicas – declínio físico progressivo e óbito, sintomas mal controlados, grande sofrimento
- ▶ TRANSPLANTE: apesar do sucesso, potenciais benefícios podem ser limitados e podem ser questionáveis diante de uma ótica com foco não só na boa função orgânica, mas o bem estar do paciente como pessoa
- ▶ Dia a dia: pacientes debilitados demais para serem submetidos ao transplante, retirados de lista quando pioram funcionalidade clínica, muitos falecem durante a longa espera pelo órgão
- ▶ Submetidos ao Tx: nem todos sobrevivem ao procedimento cirúrgico, ao período de recuperação pós cirúrgico, complicações precoces e ou tardias limitam a sobrevida a longo prazo



Integrating Palliative Care for Liver Transplant Candidates

"Too Well for Transplant, Too Sick for Life"

JAMA, 2006

Anne M. Larson, MD

J. Randall Curtis, MD, MPH

Chronic liver disease results in more than 1 million physician visits and more than 300 000 hospitalizations per

HEPATOLOGY

Official Journal of the American Association for the Study of Liver Diseases



Living and Dying Well With End-Stage Liver Disease: Time for Palliative Care?

2012

RESEARCH

Palliative care for cirrhosis: a UK survey of health professionals' perceptions, current practice and future needs

Joseph Low,¹ Victoria Vickerstaff,¹ Sarah Davis,¹ Julia Bichard,²
Lynda Greenslade,³ Katherine Hopkins,² Aileen Marshall,³
Douglas Thorburn,^{3,4} Louise Jones¹

Palliative care in patients
with liver cirrhosis: it is
the time to deal with the
burden

BMJ, 2015



Integration of Palliative Care in End-Stage Liver Disease and Liver Transplantation

Jamie Potossek, MD,¹ Michael Curry, MD,³ Mary Buss, MD,² and Eva Chittenden, MD⁴

882 *Journal of Pain and Symptom Management*

Vol. 50 No. 6 December 2015

Brief Quality Improvement Report

Benefit of Early Palliative Care Intervention in End-Stage Liver Disease Patients Awaiting Liver Transplantation

Alexandra J. Baumann, DO, David S. Wheeler, MD, PhD, Marva James, RN, Roberta Turner, MD, Arthur Siegel, MD, and Victor J. Navarro, MD

Department of Internal Medicine (A.J.B., D.S.W.), Division of Hepatology (M.J., V.J.N.), and Division of Palliative Care (A.S.), Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, Pennsylvania; and Division of Palliative Care (R.T.), Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, USA

Retrospective Study

Underutilization of palliative care services in the liver transplant population

Priya Kathpalia, Alexander Smith, Jennifer C Lai



Fases da evolução natural da doença

- CUIDADO PALIATIVO objetiva aliviar sofrimento em todas as fases da doença e não se limita ao cuidado final de vida
- Realizado em conjunto com o tratamento modificador da doença
- Melhor cuidado de suporte para otimizar doença hepática, reduzir complicações, manutenção em lista de espera, melhorar qualidade de vida, redução de hospitalizações e custos do tratamento

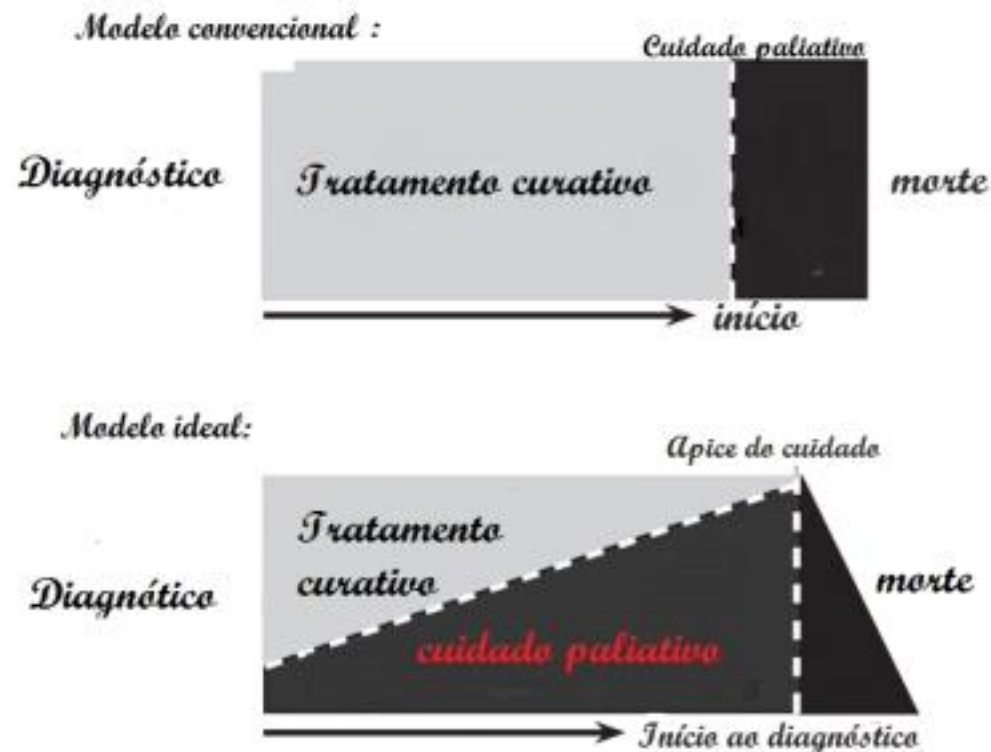


Figura 1 - Evolução dos modelos de cuidados paliativos

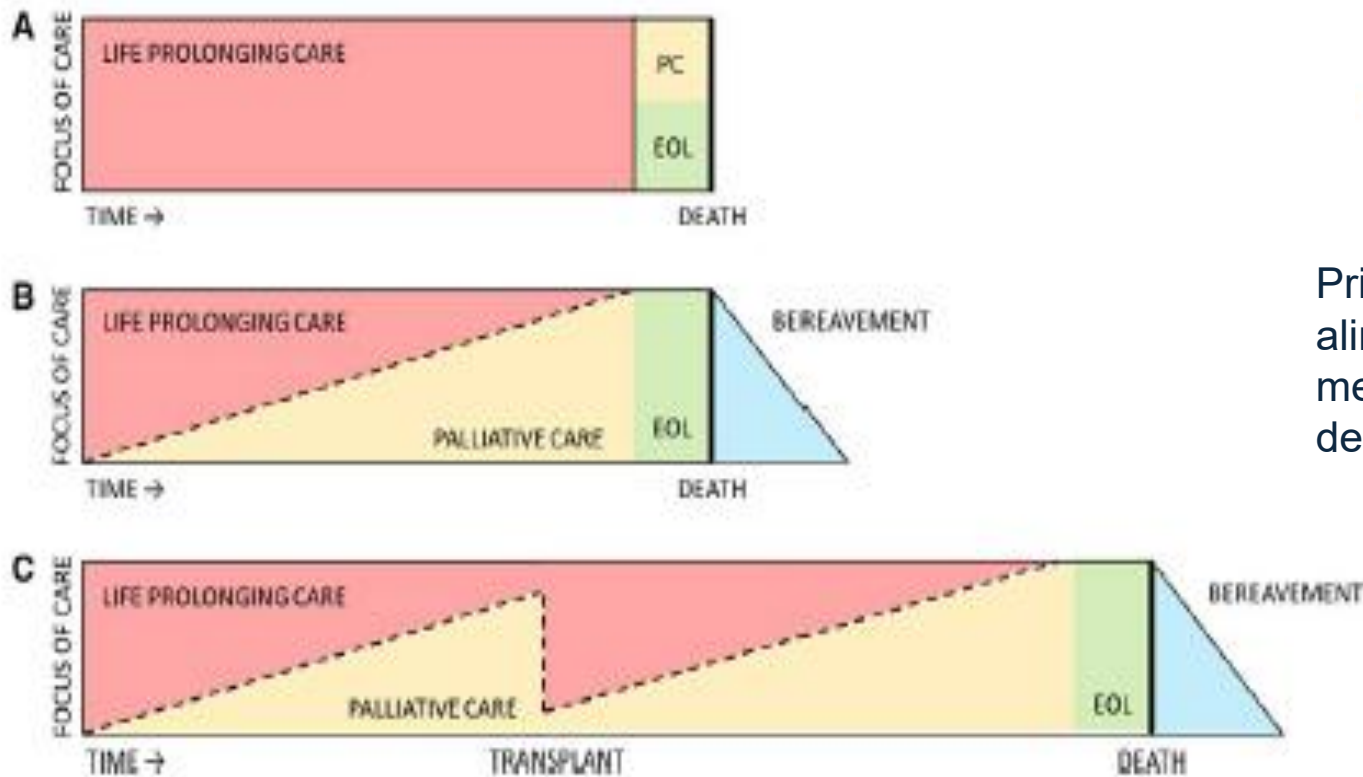
Fonte: Adaptado de JOHN V. JURICA, JANE C. NORMAN, 2015.

COMPREHENSIVE REVIEW

AJT

Palliative and end of life care in solid organ transplantation

K. Wentlandt^{1,2,3} | A. Weiss^{1,3} | E. O'Connor^{1,4} | E. Kaya^{1,5}



Principais objetivos do Transplante TOTALMENTE alinhado à filosofia paliativa = buscar sempre a melhora da qualidade de vida daqueles que sofrem de uma doença ameaçadora a vida



Palliative Care for Patients with End-Stage Liver Disease



Cyriac A. Philips^{*}, Chandan K. Kedarisetty[†]

^{}Department of Clinical and Translational Hepatology and the Monarch Liver Laboratory, Rajagiri Hospital, Aluva, Kerala, India and [†]Department of Hepatology and Liver Transplantation, Gleneagles Global Hospital, Hyderabad, India*

Abril 2023

- Sobrevida paciente com cirrose:
 - Compensada: > 12 anos x Descompensada: em torno de 2 anos
 - Descompensada > 1 admissão em 1 ano → 27% mortalidade acumulativa em 1 ano
 - Ascite: 50% mortalidade em 2 anos, se refratária reduz para 6 meses
 - EH – 12 meses
 - Infecções: aumento 4x, 1/3 morrem em 1 mês após infecção, 30% final de 12 meses



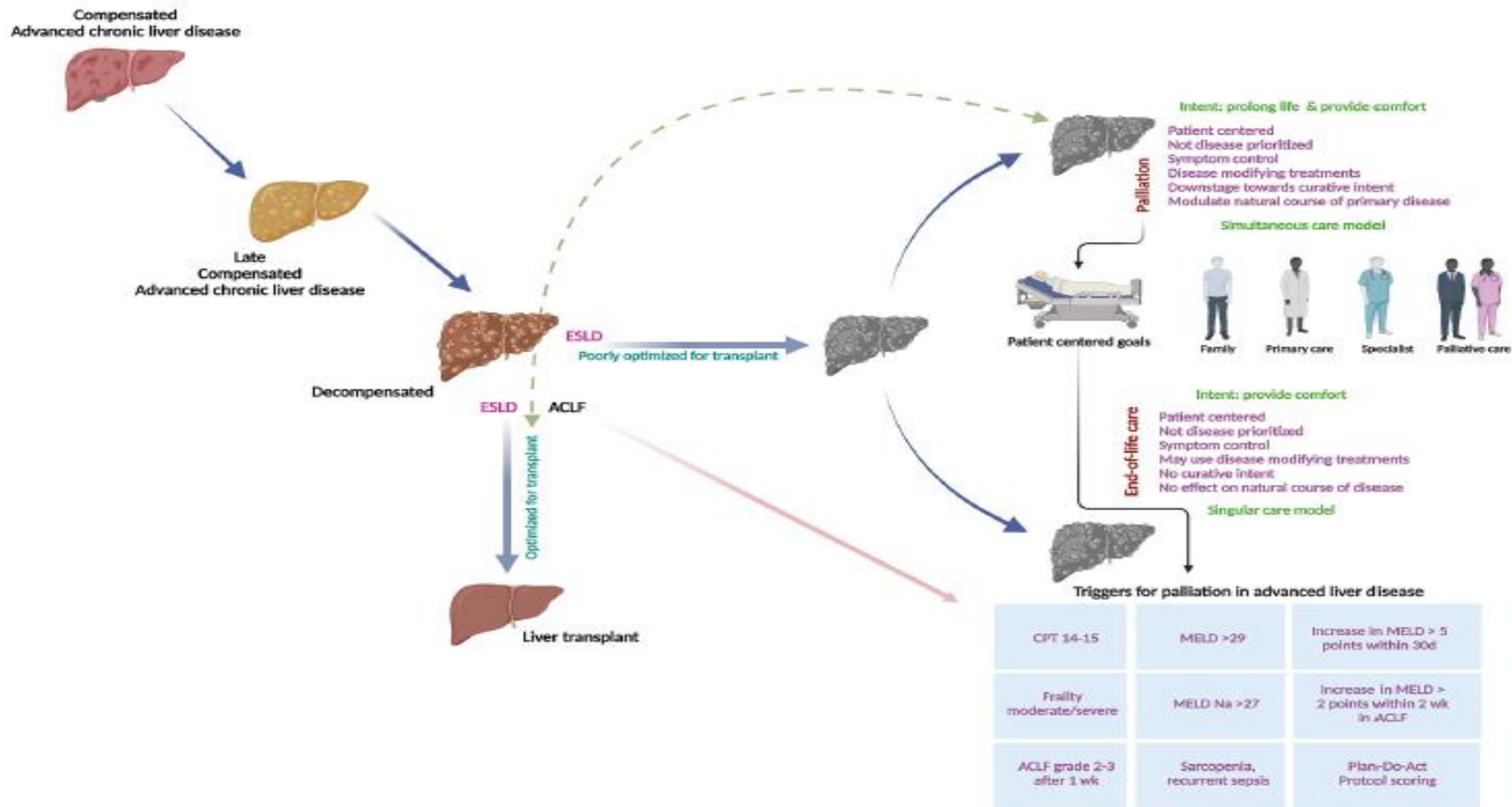


Figure 1 Definition, goals, and triggers for palliation in end-stage liver disease. CPT, Child–Pugh–Turcotte score; MELD, model for end-stage liver disease; Na, sodium; ACLF, acute-on-chronic liver failure; ESLD, end-stage liver disease.

Triggers for palliation in advanced liver disease

CPT 14-15

MELD >29

Increase in MELD > 5
points within 30d

Frailty
moderate/severe

MELD Na >27

Increase in MELD >
2 points within 2 wk
in ACLF

ACLF grade 2-3
after 1 wk

Sarcopenia,
recurrent sepsis

Plan-Do-Act
Protocol scoring



Ferramentas auxílio prognóstico x decisões terapêuticas

1) Child-Turcotte-Pugh

- Descompensação avançada: 10
- ESLD: 14-15
- Útil para prever risco de mortalidade por todas as causas e desenvolvimento de complicações
- Classe C: 45% sobrevida em 1 ano
- HDA e ascite 57% mortalidade

Escore de Child-Pugh:	1 Ponto	2 Pontos	3 Pontos
Bilirrubina (mg/dL)	< 2	2 - 3	> 3
Albumina (g/dL)	> 3.5	2.8 - 3.5	< 2.8
INR	< 1.7	1,7 - 2,3	> 2,3
Ascite	Ausente	Discreta	Tensa
Encefalopatia	Ausente	I-II	II-IV

Classificação de Child Pugh: (A) 5 a 6 pontos, (B) 7 a 9 pontos, (C) 10 a 15 pontos.



2) MELD

- mostrou-se um preditor de sobrevida
- 20-29: mortalidade em 3 meses = 19,6%
- 30-39 = 52,6%
- > 40 = 71,3%

** Delta MELD: maior risco de morte

- > 5 pontos em 30 dias: aumento 3x
- > 2 pontos em 2 semanas no ACLF

Calculadora MELD

Calculadora MELD/PELD

O valor máximo para o MELD é 40.

Creatinina sérica (mg/dL) - mínimo 1.0, máximo 4.0	1
Bilirrubina total (mg/dL) - mínimo 1.0	1
RNI - mínimo 1.0	1
Calculate	
Reset	



3) Fragilidade

- Avaliação sarcopenia
 - Redução força física
 - Redução capacidade exercício aeróbico
 - Deficiência física
 - Medem força física, fadiga subjetiva, funcionalidade, equilíbrio
-
- ▶ Escores: Fried Frailty Index, Rockwood, escalas de fragilidade clínica, escala de Braden, pontuação velocidade de marcha, pontuação atividades de vida diárias, teste caminhada por minuto
 - ▶ Tolerância reduzida e reserva para suportar a descompensação
 - ▶ Aumento de 1 ponto escore de fragilidade: aumento 50% mortalidade lista espera Transplante
 - ▶ A cada 100m redução no teste de caminhada por 6 minutos: aumento 48% mortalidade
 - ▶ Fragilidade: risco 2x maior morte fila Tx



Escala Clínica de Fragilidade*



1. Muito Ativo - Pessoas que estão robustas, ativas, com energia e motivadas. Essas pessoas normalmente se exercitam regularmente. Elas estão entre as mais ativas para a sua idade.



2. Ativo - Pessoas que não apresentam nenhum sintoma ativo de doença, mas estão menos ativas que as da categoria 1. Frequentemente se exercitam ou são muito ativas ocasionalmente, exemplo: em determinada época do ano.



3. Regular - Pessoas com problemas de saúde bem controlados, mas não se exercitam regularmente além da caminhada de rotina.



4. Vulnerável - Apesar de não depender dos outros para ajuda diária, frequentemente os sintomas limitam as atividades. Uma queixa comum é sentir-se mais lento e/ou mais cansado ao longo do dia.



5. Levemente Frágil - Estas pessoas frequentemente apresentam lentidão evidente e precisam de ajuda para atividades instrumentais de vida diária (AIVD) mais complexas (finanças, transporte, trabalho doméstico pesado, medicações). Tipicamente, a fragilidade leve progressivamente prejudica as compras e passeios desacompanhados, preparo de refeições e tarefas domésticas.



6. Moderadamente Frágil - Pessoas que precisam de ajuda em todas as atividades externas e na manutenção da casa. Em casa, frequentemente têm dificuldades com escadas e necessitam de ajuda no banho e podem necessitar de ajuda mínima (apoio próximo) para se vestirem.



7. Muito Frágil - Completamente dependentes para cuidados pessoais, por qualquer causa (física ou cognitiva). No entanto, são aparentemente estáveis e sem alto risco de morte (dentro de 6 meses).



8. Severamente Frágil - Completamente dependentes, aproximando-se do fim da vida. Tipicamente incapazes de se recuperarem de uma doença leve.



9. Doente Terminal - Aproximando-se do fim da vida. Esta categoria se aplica a pessoas com expectativa de vida < 6 meses, sem outra evidência de fragilidade.

Pontuando fragilidade em pessoas com demência

O grau de fragilidade corresponde ao grau de demência. Sintomas comuns na demência leve incluem esquecimento dos detalhes de um evento recente, apesar da recordação do evento em si, repetindo a mesma pergunta/história e afastamento de eventos sociais.

Na demência moderada, a memória recente está muito comprometida apesar de aparentemente lembrar bem de fatos do passado. Quando solicitadas, elas são capazes de fazer o cuidado pessoal.

Na demência severa, elas não conseguem realizar cuidados pessoais sem ajuda.

* 1. Canadian Study on Health & Aging. Revised 2008.

2. K. Rockwood et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005; 113:489-495.

©2009. Version 1.2_EN; ©2018. Version 1.0_Port. All rights reserved. Geriatric Medicine Research, Dalhousie University, Halifax, Canada. Permission granted to copy for research and educational purposes only.



4) Escores UTI – probabilidade morte

- SAPS, APACHE, SOFA melhores preditores do que os escores de cirrose (MELD, CHILD)
- SOFA (falências orgânicas) – melhor deles

Cirrhotic patients in the ICU: prognostic markers and outcome

Faouzi Saliba^{a,b,c}, Philippe Ichaï^{a,c}, Eric Levesque^{a,c}, and Didier Samuel^{a,b,c}

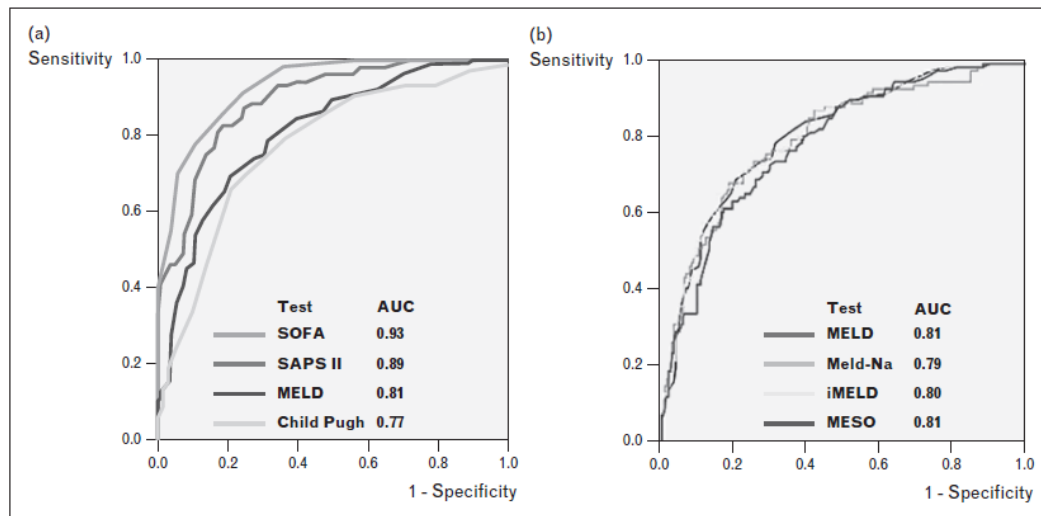


FIGURE 1. Prognostic scores (AUC-ROC) of critically ill cirrhotic patients admitted to ICU. (Paul Brousse Hospital experience in 377 patients). AUC-ROC, area under the curve-reciever operating characteristic. Adapted with permission from [9].

Prognostic scores for cirrhotic patients admitted to an intensive care unit: Which consequences for liver transplantation?

Arnaud Galbois^{a,b,c,*}, Vincent Das^d, Nicolas Carbonell^e, Bertrand Guidet^{a,b,f}

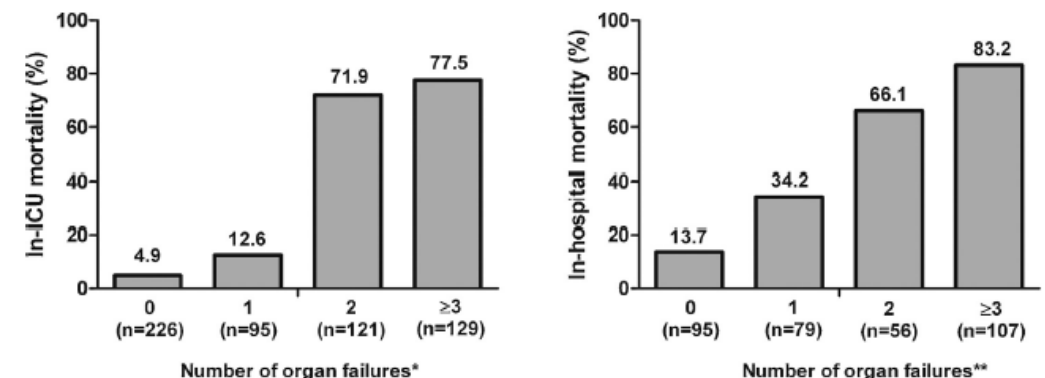


Figure 1 Mortality of cirrhotic patients according to the number of organ failures on the first day in intensive care unit. An organ failure is defined by a Sequential Organ Failure Assessment score ≥ 3 for any individual organ. *: In-intensive care unit mortality is obtained pooling the results of Levesque et al. [54], Das and Galbois et al. [28,67]. **: In-hospital mortality is obtained pooling the results of Wehler et al. [49], Das and Galbois et al. [28,67].

5) CLIF C ACLF

- Escore SOFA modificado para englobar características específicas da cirrose
- Maior previsibilidade para mortalidade em 28 dias e 90 dias
- > 4 disfunções orgânicas e CLIF C ACLF > 64 → avaliar futilidade terapêutica
- Trial de UTI sem melhora após 3 a 7 dias

Órgão/sistema	Variável	Pontuação = 1	Pontuação = 2	Pontuação = 3
Fígado	Bilirrubina (mg/dL)	<6	6 a ≤12	>12
Rim	Creatinina (mg/dL)	<2	2 a <3,5	≥3,5 ou TRS
Cérebro	Grau de encefalopatia (West-Haven)	0	1-2	3-4
Coagulação	INR	<2	2 a <2,5	≥2,5
Circulação	PAM (mm Hg)	≥70	<70	Vasopressores
Respiratório	PaO ₂ /FiO ₂ ou SpO ₂ /FiO ₂	>300 >357	≤300 e >200 >214 e ≤357	≤200 ≤214

Pontuação CLIF-C OFs: versão simplificada da pontuação CLIF-SOFA



Variables	Data	CLIF-C OF score
Bilirubin	10 mg/dL	Liver score 2 Liver failure ☐ Yes ☒ No
Creatinine	2 mg/dL	Kidney score 3 Kidney failure ☒ Yes ☐ No
Renal replacement therapy	☒ Yes ☐ No	
West-Haven grade for hepatic encephalopathy (HE)	☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4	Brain score 2 Brain failure ☐ Yes ☒ No
International normalized ratio (INR)	3	Coagulation score 3 Coagulation failure ☒ Yes ☐ No
Mean arterial pressure (MAP)	65 mmHg	Circulatory score 3 Circulatory failure ☒ Yes ☐ No
Use of vasopressors (circulatory failure indication)	☒ Yes ☐ No	
Select one: ☒ PaO ₂ (preferred) ☐ SpO ₂	95 mmHg 95 %	Respiratory score 1 Respiratory failure ☐ Yes ☒ No
FiO ₂	30 %	
Mechanical ventilation (respiratory failure indication)	☐ Yes ☒ No	
		Total no. of organ failures 3 CLIF-C OF score 14 ACLF grade ACLF-3



EFCLIF

EUROPEAN FOUNDATION
FOR THE STUDY OF
CHRONIC LIVER FAILURE

CLIF

Variables	Data	CLIF-C ACLF score and probability of death
Age	55 years	
White blood cell count	10 x 10 ⁹ cells/L	
		CLIF-C ACLF score 63
		1-month mortality 68 %
		3-month mortality 84 %
		6-month mortality 87 %
		12-month mortality 90 %



A difícil arte de prognosticar

- Avaliação prognóstico não é simples, podemos fazer uso de algumas ferramentas – PPS, CLIF ACLF (trial de UTI)
- PPS – Palliative performance scale – avalia funcionalidade prévia e identificação do declínio clínico

Tabela 2 – Escala de Performance Paliativa (PPS)					
%	Deambulação	Atividade e evidência da doença	Auto-cuidado	Ingestão	Nível da Consciência
100	Completa	Normal; sem evidência de doença	Completo	Normal	Completa
90	Completa	Normal; alguma evidência de doença	Completo	Normal	Completa
80	Completa	Com esforço; alguma evidência de doença	Completo	Normal	Completa
70	Reduzida	Incapaz para o Trabalho; alguma evidência de doença	Completo	Normal ou reduzida	Completa
60	Reduzida	Incapaz de realizar hobbies; doença significativa	Assistência ocasional	Normal ou reduzida	Períodos de confusão ou completa
50	Sentado ou deitado	Incapacitado para qualquer trabalho; doença extensa	Assistência Considerável	Normal ou reduzida	Períodos de confusão ou completa
40	Acamado	Idem	Assistência quase completa	Normal ou reduzida	Períodos de confusão ou completa
30	Acamado	Idem	Dependência Completa	Reduzida	Períodos de confusão ou completa
20	Acamado	Idem	Idem	Ingestão limitada a colheradas	Períodos de confusão ou completa
10	Acamado	Idem	Idem	Cuidados com a boca	Confuso ou em coma
0	Morte	—	—	—	—

Meu tratamento está sendo fútil? Quando interromper o trial de UTI?

A tomada de decisão sobre as prioridades de cuidado envolve:

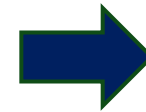
- Aspectos biológicos
- Funcionalidade prévia (PPS)
- Valores da bioética (autonomia, justiça, beneficência e não maleficência)
- Proporcionalidade entre:
 - A eficácia do tratamento proposto: conhecimento médico técnico sobre a diferença que o tratamento faria em termos de prognóstico, incluindo morbidade, mortalidade ou funcionalidade, segundo as melhores evidências disponíveis (sugere-se que o Índice de prognóstico SOFA seja monitorado)
 - O benefício: determinação subjetiva do que o paciente ou seu representante legal percebem como sendo de valor para seu próprio bem, segundo seus objetivos ligados ao tratamento proposto
 - A onerosidade da intervenção: custos físicos, emocionais, econômicos ou sociais impostos ao paciente pelo tratamento.



- Diante das limitações e potenciais complicações → discussão + realística e ética sobre os benefícios que poderemos proporcionar
- Transparência relação médico-paciente e familiares
- Comunicação empática
- Real empoderamento do paciente e familiares – AUTONOMIA
- Atenção – nossos valores podem ser diferentes do paciente e família

➤ Escolha melhor tratamento:

- Riscos e benefícios
- Dificuldade de obtenção a tempo do órgão
- Cenário de aflição, esperança, expectativas frustradas



Espaço reflexão
valores e reais
desejos dos
pacientes



O que faz sentido para o seu paciente

- Direcionamento sobre diretiva antecipada de vontade
- Escuta de valores e preferências
- Abordagem precoce sobre CP



- Minimizar as surpresas e traumas emocionais de pacientes e famílias

“Pacientes e familiares só farão as melhores escolhas sobre o momento de aceitar o fim da vida se nós, médicos, formos honestos sobre os prováveis resultados dos tratamentos que temos a oferecer.”

KATHRYN MANNIX

Apesar literatura escassa...

- Identificação precoce estágio doença
- acompanhamento multiprofissional pacientes e familiares
- Planejamento cuidados
- Manejo adequado de sintomas – farmacológicos e não farmacológicos



- Evita internações frequentes
- Melhora qualidade de vida
- Promove final de vida com conforto e dignidade



- Iniciar ou não TRS no paciente cirrótico???
- Sempre um desafio
 - Ponte para pacientes candidatos a Tx?
 - Maior mortalidade em todos os grupos

DOI: 10.1111/liv.13431

EDITORIALS

WILEY



Renal replacement therapy in critically ill cirrhotic patients: A challenging balance between efficacy and futility



Revisão Cuidados Paliativos na população com doença hepática terminal

- ▶ Pacientes em lista para Transplante: 26% retirados por uso de substâncias e 25% por disfunção orgânica progressiva
- ▶ Destes: 17% TRS, 48% admitidos UTI, 10% encaminhados para Cuidados Paliativos
- ▶ 14% hospitalizados por complicações foram readmitidos após 1 semana, 30-37% em 1 mês, 50% em 3 meses
- ▶ Em média 3 internações/paciente/ano
- ▶ Maioria encaminhado para CP apenas nas 2 últimas semanas de vida → não é eficaz

Estudo estruturado de intervenção em CP para pacientes cirróticos e transplantados hepáticos UTI cirúrgica:

- 1ª intervenção: revisão prognóstico, abordagem de diretivas e controle de sintomas em 24h
- 2ª reunião familiar para revisar metas de cuidado

→Diretivas de cuidado: 2 para 38%

→Taxa de não RCP: 52 para 81%

→Withdrawn: 35 para 68% sem alteração mortalidade

→Redução tratamentos fúteis

→Redução custos



INDICATIONS FOR PALLIATIVE CARE IN CIRRHOSIS

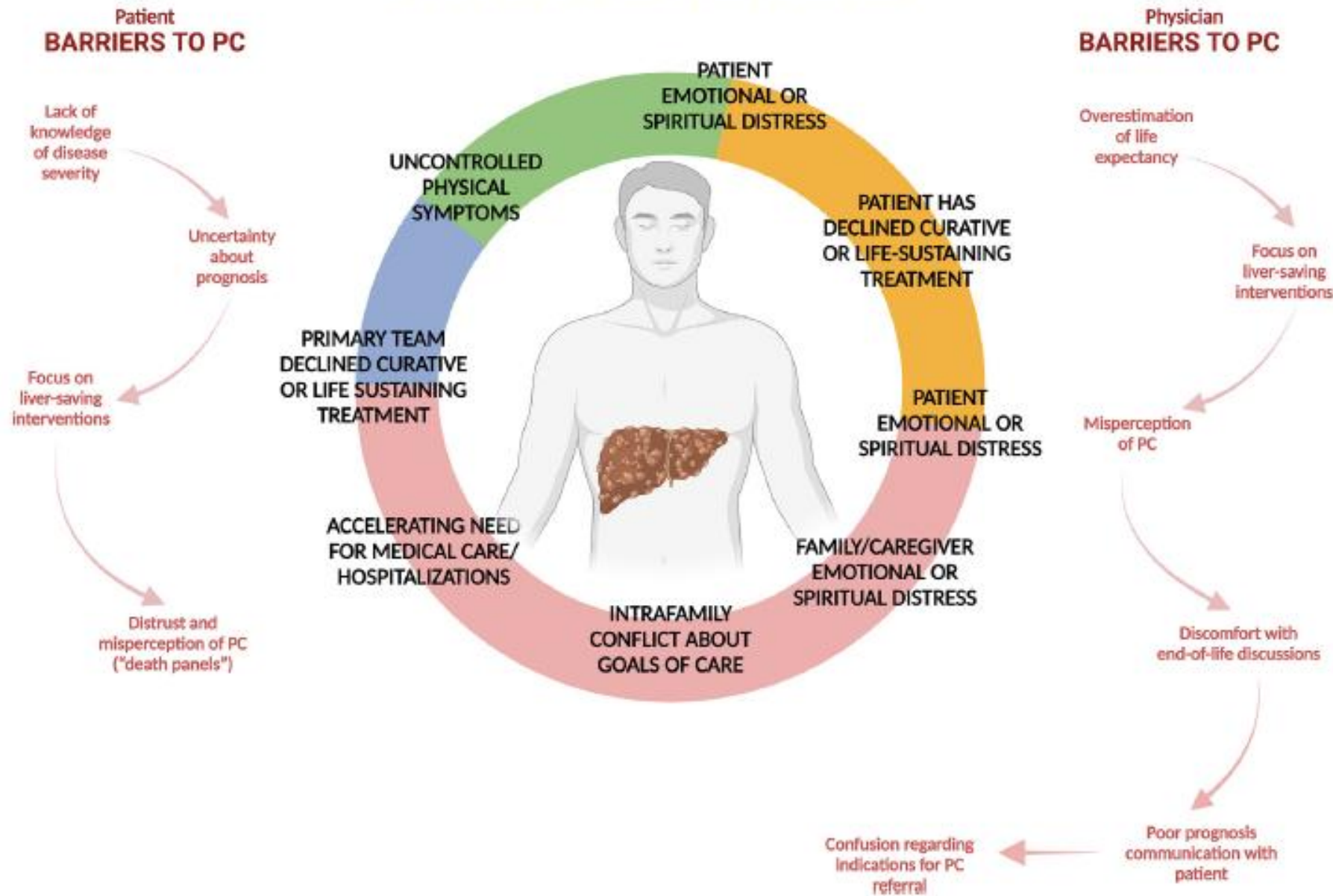


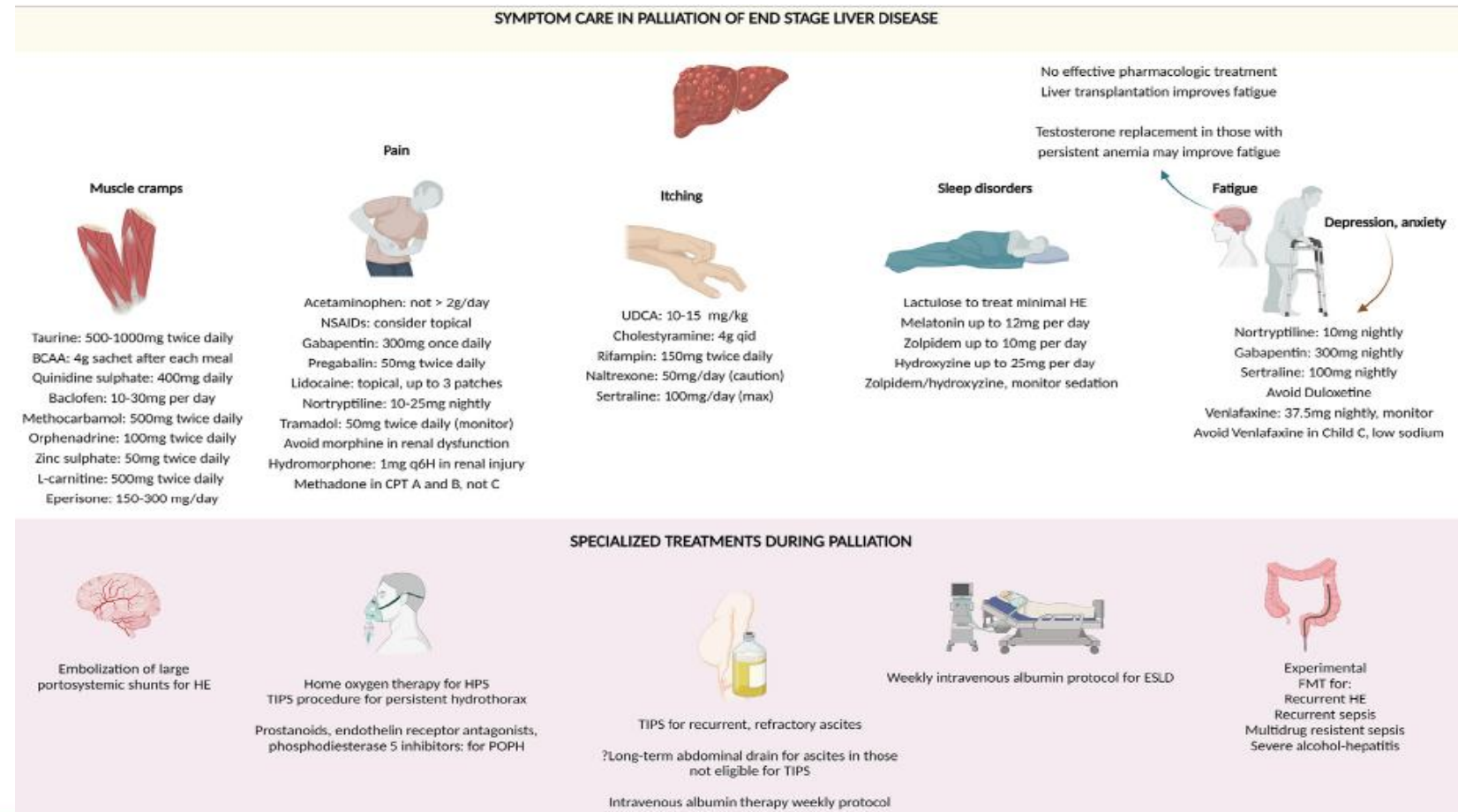
Figure 2 Indications for palliation in patients with advanced liver disease. The infographics also depict barrier to palliative care initiation from patient and physician point of view. PC, palliative care.



Manejo de sintomas

- 72% relatam má qualidade de vida geral
- Dor 30-79%
- Falta de ar 20-88%
- Câimbras 56-68%
- Insônia 26-77%
- Sonolência diurna 29,5-71%
- Depressão 4,5-64%
- Ansiedade 14-45%

Figure 3 Brief summary of various treatment options for reducing symptom burden and improving quality of life in patients with advanced liver disease on palliation. BCAA, branched-chain amino acids; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs; CPT, Child–Pugh–Turcotte score; UDCA, urso-deoxycholic acid; HE, hepatic encephalopathy; FMT, fecal microbiota transplantation; TIPS, transjugular intrahepatic portosystemic shunt; HPS, hepatopulmonary syndrome; POPH, portopulmonary hypertension.



REVIEW ARTICLE

Edward W. Campion, M.D., Editor

Palliative Care for the Seriously Ill

Amy S. Kelley, M.D., M.S.H.S., and R. Sean Morrison, M.D.

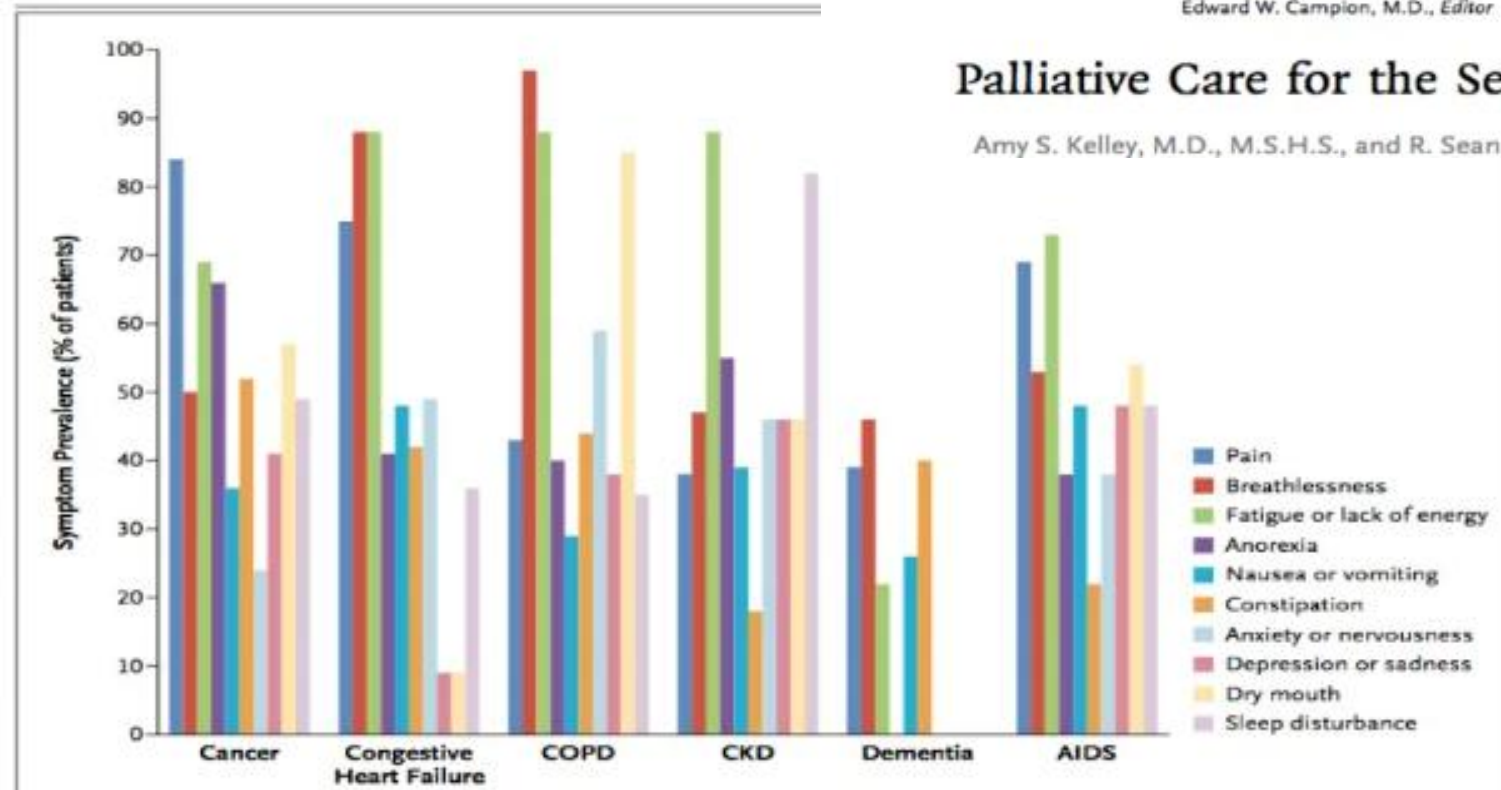


Figure 1. Symptom Prevalence in Advanced Illness.

Data are from representative studies of symptom prevalence among patients with cancer,⁸⁻¹² congestive heart failure,^{13,14} chronic obstructive pulmonary disease (COPD),¹⁵ chronic kidney disease (CKD),^{13,14} or dementia^{16,17} and among patients who received highly active antiretroviral therapy for the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS).¹⁸ Self-reported data regarding some symptoms were unavailable for patients with dementia.

- Dor
- Dispneia
- Náuseas e vômitos
- Constipação
- Delirium
- Agitação
- Sialorréia
- Xerostomia
- Fadiga



Manejo clínico sintomas prevalentes

- Fase assintomática da cirrose compensada → HP + complicações (ascite, PBE, varizes e hemorragia, EH, coagulopatia, CHC, SHR, SHP)
- Sintomas mais frequentes: fadiga, dor, prurido, câimbras, anorexia, caquexia, depressão



Ascite

- Impacto vida social e profissional
- Frequentemente leva a hospitalização
- PBE, disfunção ventilatória restritiva, hérnia abdominal
- Piora prognóstico



Paracentese na Ascite maligna

- Fase final de vida em vários tipos de câncer (**estender para cirrótico ascite refratária sem perspectiva de transplante...)
- Etiologias: mais frequente Ca ovário, endométrio, pâncreas, colorretal, mama, esôfago, estômago, pulmão, hepatobiliar, peritoneal primário
- Sobrevida média após diagnóstico ascite – 3 a 6 meses não ovariano, refratário 1 a 2 meses
- Dor, desconforto abdominal, distensão, náuseas e vômitos, dispneia, fadiga, anorexia
- Alívio sintomático paliativo = PARACENTESE



- Procedimentos repetidos: hospitalização frequente, DHE, maior risco peritonite, complicações (sangramentos, perfuração alça)
- Sem diretrizes claras – em geral diuréticos e restrição alimentar não são suficientes
- Possibilidade de expectativa de vida maior – **INSERÇÃO DE CATETER TUNELIZADO**
- Poucos estudos: reduz admissão hospitalar, duração internação, frequência idas a emergência, reduz gastos em saúde



Hemorragia digestiva

- Individualizar tratamento
- Possibilidade terapêutica
- Trial de UTI full, algumas limitações
- Final de vida
- Lençóis escuros
- Impossibilidade terapêutica – orientar paciente e familiares, considerar sedação paliativa, conforto



PBE → tratamento convencional

Encefalopatia hepática

- Lactulose, LOLA, neomicina, rifaximina, metronidazol...
- Não indicar dieta hipoprotéica
- Até quando manter medidas... Próximo fase ativa lembrar que a própria doença seda o doente, uso de dose mais baixas de sedativo

Síndrome hepatorrenal

- Tentar tratamento farmacológico
- Individualizar indicação Terapia renal substitutiva – paciente candidato a Tx, diálise será ponte para, possibilidade de recuperação



DOR

- Muitas medicações de metabolização hepática, maior risco efeitos adversos, menor dose necessária

**Bomba morfina
Diluição 1mg.ml
Iniciar em 0.5ml.h
e titular**

**Se sinais de intoxicação
– avaliar se é caso ou
não de reverter com
naloxone – 0.04mg > 0.5
> 2 > 4 > 10 > 15mg**



**Tratamento não farmacológico: massagem,
acupuntura, psicoterapias, posicionamento,
eletrotermoterapia...
Lembrar de dor total!!! (física, emocional, social,
espiritual)**



PRURIDO



- Pacientes com colestase
- Generalizado ou localizado (palma mão e planta pé)
- Emolientes tópicos, evitar fricção pele nos banhos, ar frio e umidificado, sabonetes líquidos, evitar perfumes, usar roupas folgadas, lençóis macios
- Moderado ou intenso:
 - Colestiramina 12 a 24g dia 3xdia
 - Ondansetrona 4mg 2xdia
 - Naltrexona – evitar – reduz analgesia em pacientes em uso de opióide
 - Fenobarbital a noite
- Anti histamínicos: clorfeniramina 4 a 12 mg 3 a 4xdia, cetirizina 5mg 2xdia ou 10mg 1x, hidroxizina 10 a 25mg 2 a 3xdia ou 25-100mg noite, prometazina 25-50mg 2xdia
- Antidepressivos: paroxetina 5-20mg manhã (resposta em 24-48h, suspender se ausência resposta após 4-7 dias), mirtazapina 7,5-15mg noite (monoterapia ou associada a paroxetina)



CÃIMBRA



- Corrigir DHE
- Relacionados a cirrose – espontâneas, crônicas e noturnas
- Tratamento não farmacológico – alongamento, andar e mexer nas pernas seguido de elevação, banho quente, massagem com gelo
- Medicamentoso: vitamina B, vitamina E, difenidramina 12,5-50mg noite, diltiazem 30mg, verapamil 120-180mg noite, gabapentina 600-900mg

Anorexia e caquexia

- Ajuste aporte nutricional
- Avaliar se faz sentido SNE para alimentação suplementar, indicação NPP



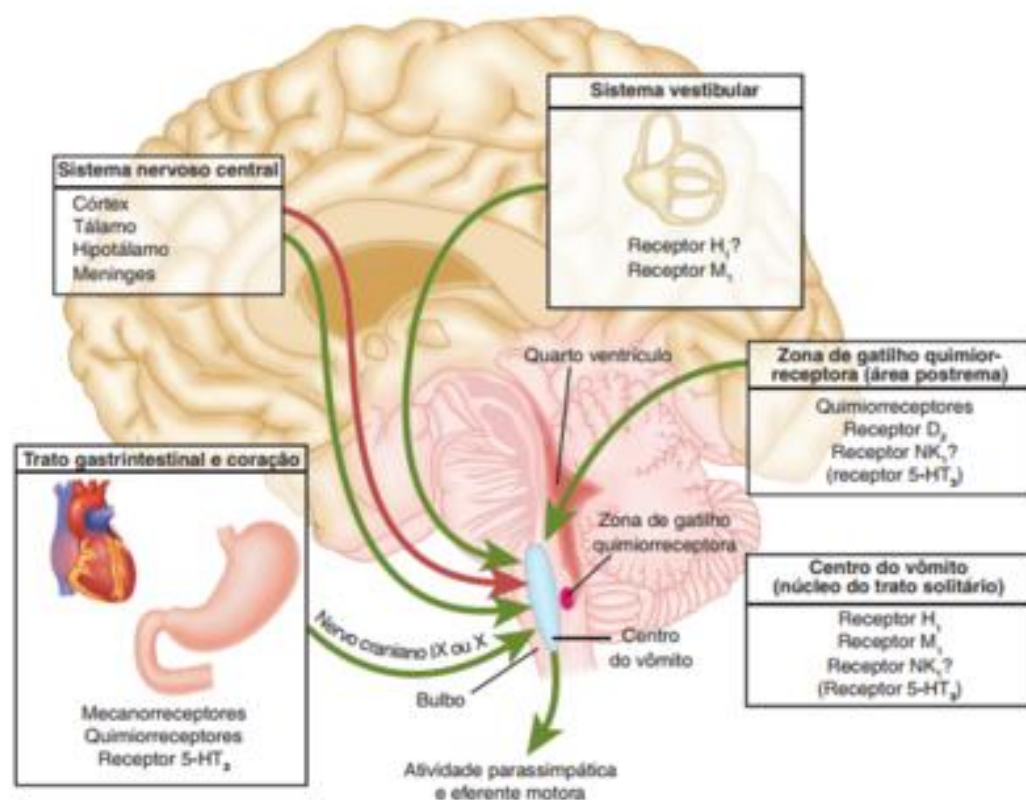
Dispneia



- Sinais NÃO mensuram dispnéia (tiragem, taquipnéia, uso musculatura acessória)
- Padrão ouro – queixa paciente
- Exame físico, laboratoriais, imagem
- Tratar causa base – corticóide, broncodilatador, diurético, O₂, drenagem pleural, pericárdica, paracentese, pleurodese, transfusão, fisioterapia, VNI, CNAF... → objetivo CONFORTO do paciente
- Principal linha tratamento – opióides – morfina 0.5 a 2mg.h infusão contínua
- Lembrar que morfina não trata padrão respiratório – evolução gasping – aumento progressivo da dose vai gerar bradipnéia e falsa impressão de melhora - intoxicação



Náuseas e vômitos



- Diferentes mecanismos e receptores
- Opções tratamento:
- Procinéticos metoclopramida (estase gástrica, hipomotilidade), domperidona e bromoprida, eritromicina
- Neurolépticos – haldol 1-2mg 8 em 8h até 5mg 6 em 6h, olanzapina
- Fenotiazinas - clorpromazina (ampticil) e levomepromazina (neozine) – boa opção causa intestinal, vestibular ou 2ª linha – inicial 5 a 8gts
- Anihistaminicos: difenidramina (dramin), prometazina (fenergan)
- Anti colinérgicos: escopolamina, hioscina (buscopam) – boa opção causa intestinal – obstrução, irritação peritoneal
- Corticóides – dexta 4 a 16mg dia, metipred 1 a 4mg.kg dia
- Antagonistas 5HT3: ondansetrona
- Análogos de somatostatina – octreotide – causa intestinal – reduz secreções
- Benzodiazepínicos – náusea antecipatória ou associada a sofrimento emocional
- Antagonista substância P (NK1) – aprepitan
- Canabinóides – em QT



Fadiga

- Sensação subjetiva de cansaço, fraqueza ou perda de energia
- Diferenciar entre causa (anemia, infecção, febre, desidratação, DHE...) e sintoma
- Tratamento farmacológico:
- Corticóide dexametasona 8mg dia 2 semanas
- Ritalina (câncer) , megestrol (câncer, AIDS), modafinil (câncer, EM), L carnitina, ginseng, guaraná
- Tratamento não farmacológico: atividade física, higiene sono, conservação energia, psicoterapia, meditação, yoga, acupuntura, aromaterapia, massagem

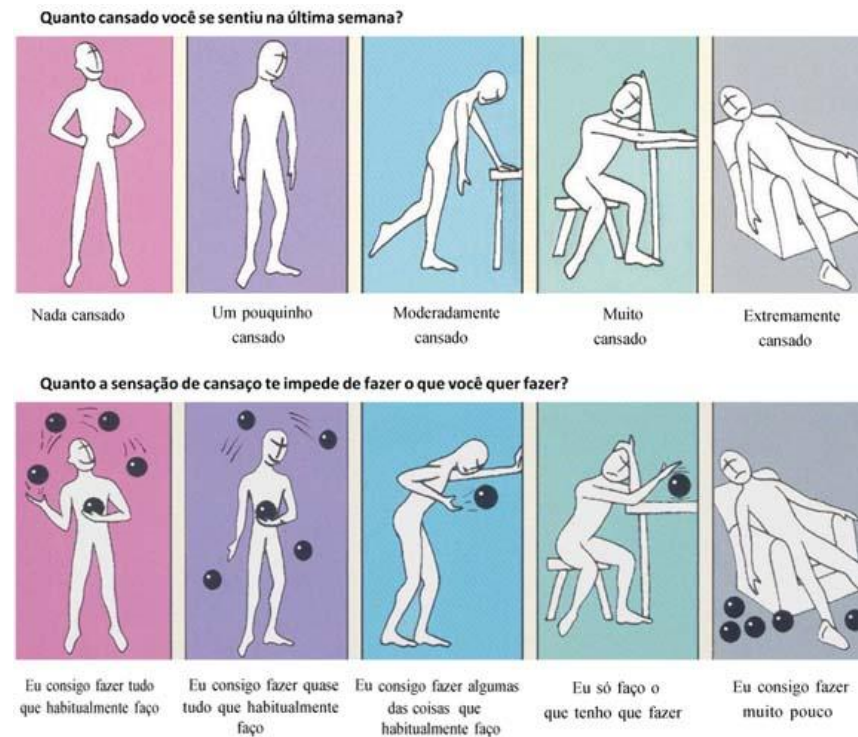


Figura 1 - Pictograma de Fadiga



Sedação paliativa



- Sintomas refratários que mais frequentemente indicam sedação paliativa – delirium, dor, dispneia
- Medida extrema – avaliação por especialista
- Tempo entre instalação e morte: 2 a 4 dias – 47% 24h, 45% 7 dias, 8% 1-2 semanas
- Mínima dose para controle do sintoma, exceto sangramento, obstrução via aérea
- Contínua x intermitente
- Droga escolha midazolam – 1mg.ml – dose 1 a 20mg.h
- Se sintomas psicoexistenciais – evitar sedação! Suporte Psico e Psiquiatria



Cenário

- Imprevisibilidade da evolução da doença, com muitas intercorrências, agudizações e hospitalizações é pertinente questionar: quando indicar ou iniciar o acompanhamento com equipe de cuidados paliativos
- Não espere o seu paciente ficar encefalopata para discutir objetivo de cuidado, alinhar expectativas desde ambulatório, enfermaria e depois UTI e não o caminho inverso
- Realidade → falta de acesso a equipes de CP, acionados quando paciente é removido da lista, quando estão na UTI, quando estão em DMOS



- ▶ Recente foco de CP na doença hepática terminal
- ▶ Possibilidade de transplante como tratamento curativo é um dos motivos do CP ser pouco considerado
- ▶ Parece contra intuitivo iniciar para paciente considerados para Tx → não são excludentes
- ▶ Iniciar quando... Assim como câncer no diagnóstico
- ▶ A abordagem pode ser feita inicialmente pelos clínicos, gastro e hepatologistas
- ▶ Objetivo: alívio sofrimento físico, emocional, social e espiritual, controle de sintomas, discussão e estabelecimento objetivos de cuidado, ajuda na comunicação com vários membros do time de cuidado, suporte pacientes e cuidadores



Suporte psicológico

- Tratar sintomas físicos para conseguir abordar os psicológicos
- Paciente e família precisam entender a doença e o prognóstico para conseguirem discutir objetivos de cuidado
- Cientes das possibilidades de evolução – tempo para se organizarem, significar a finitude





Desafios

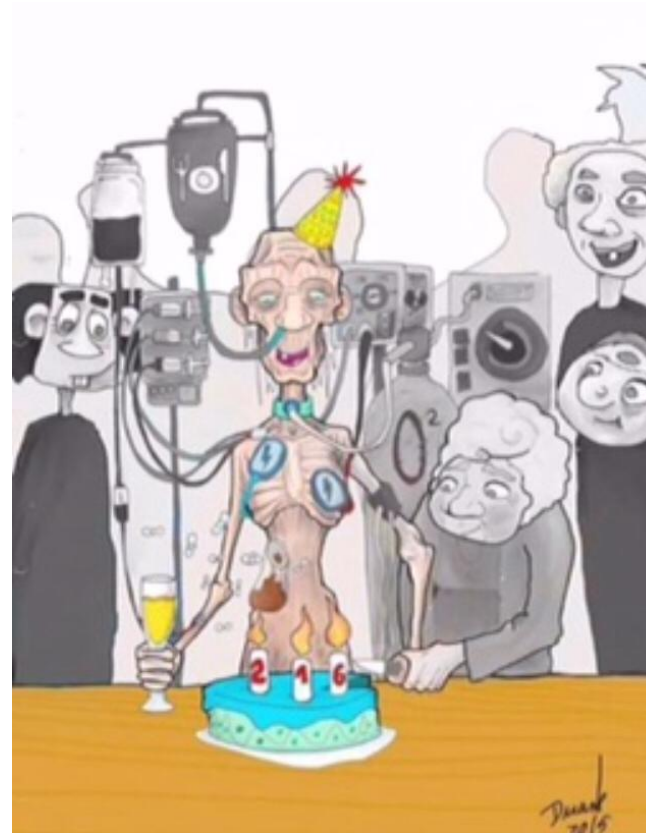
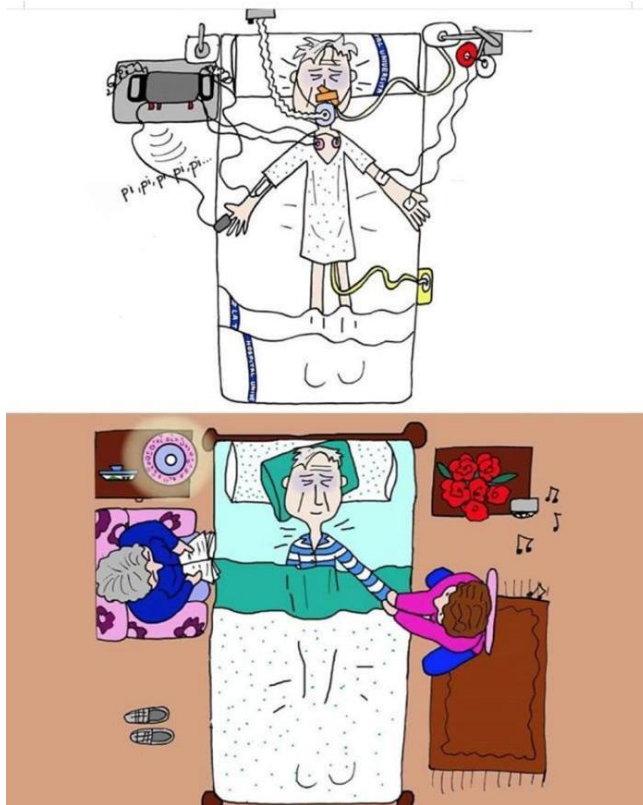
- Mudanças no Ensino: formar profissionais mais sensíveis e atentos aos novos horizontes que se apresentam à prática na saúde
- EDUCAR: - não é simplesmente instruir, mas aperfeiçoar a formação do caráter de uma pessoa, além de habilidades técnicas, “formar” profissionais que respeitem os valores éticos distintos daqueles que lhes são próprios





“A morte faz parte da vida”

“O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida” (Cicely Saunders)



Pontos chaves

- Estimular a discussão sobre prognóstico e diretivas de cuidado desde o atendimento ambulatorial
- Pacientes com cirrose avançada são candidatos a seguimento com Cuidados Paliativos
- Transplante e CP não são excludentes!
- CLIF C ACLF nos auxilia a definir falha no trial de UTI
- Quando paciente e família dizem querer que “tudo seja feito”, muitas vezes isso significa “não me abandone”, cabe a nós profissionais de saúde orientarmos e estarmos ao lado em todas as fases do tratamento seja ele curativo ou paliativo e não perpetuando terapias fúteis por falhas nossas de comunicação.



Obrigada!

Dúvidas : gastrointensiva@gmail.com

